

Manual da Política de Saúde da Criança

1 INDICADORES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS)

São os indicadores utilizados pelo MS para acompanhamento da saúde infantil:

- Ter a 1ª consulta presencial realizada por médica(o) ou enfermeira(o), até o 30º dia de vida;
- Ter pelo menos 09 (nove) consultas presenciais ou remotas realizadas por médica(o) ou enfermeira(o) até dois anos de vida;
- Ter pelo menos 09 (nove) registros simultâneos de peso e altura até os dois anos de vida;
- Ter pelo menos 02 (duas) visitas domiciliares realizadas por ACS/TACS, sendo a primeira até os primeiros 30 (trinta) dias de vida e a segunda até os 06 (seis) meses de vida;
- Ter vacinas contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por *Haemophilus influenzae* tipo b, poliomielite, sarampo, caxumba e rubéola, pneumocócica, registradas com todas as doses recomendadas.

Para que as informações sejam validadas na consulta no MV e migrem adequadamente para o e-sus devemos atentar para:

- O profissional que está realizando a consulta no SOAP (médico ou enfermeiro) deve registrar peso e altura no ícone de “**Antropometria**” OU “**Preparo**” (Figura 1).
- No campo “Avaliação” precisa colocar o **CIAP A98**, independente de inserir outros códigos ou CID.
- Incluir em procedimento: “**Avaliação do crescimento na puericultura**” e “**Avaliação do desenvolvimento na puericultura**”. (Figura 2)

TODAS AS CRIANÇAS DE 0-2 ANOS pertencentes ao território precisam estar com cadastro atualizado e ficha individual completa, vinculado a equipe de saúde antes de realizar a consulta para validar as informações.

Figura 1: Peso e altura em todas as consultas (médico ou enfermeiro).

A imagem mostra a interface do sistema de saúde (e-SUS) durante uma consulta. No topo, há uma barra de navegação com opções como 'Hipótese Diagnóstica', 'Histórico Familiar/Antecedentes', 'SOAP', 'Lista de Problemas', 'Plano de cuidado', 'Cuidado compartilhado' e 'Dados de Saúde'. Abaixo, há uma seção 'SUBJETIVO' com campos para 'Motivo da consulta / Queixa do Paciente / Entrevista Clínica', 'CIAP2 - Classificação Internacional de Doenças', 'Observação / Nota' e botões 'Adicionar' e 'Limpar'. À direita, há um menu suspenso com opções: 'Dados de Saúde / Resumo clínico', 'Informações de Preparo', 'Não Realizado Acolhimento' e 'Fechar'. Abaixo, há uma tabela com colunas 'CIAP2 Descrição', 'Observação' e 'Motivo'. Na base, há uma seção 'OBJETIVO' com o campo 'Exames Físicos e Complementares' e botões 'Adicionar' e 'Antropometria / Glicemia capilar Sinais vitais'. Duas setas azuis circulares destacam os botões 'Antropometria / Glicemia capilar Sinais vitais' no menu suspenso e no campo de exames físicos.

Figura 2: Procedimento avaliação do crescimento e avaliação do desenvolvimento na puericultura.

PARA VALIDAR CONSULTA DE PUERICULTURA:

- REGISTRAR NO CAMPO AVALIAÇÃO O CÓDIGO A98 - MEDICINA PREVENTIVA/MANUTENÇÃO DA SAÚDE;
- REGISTRAR COMO PROCEDIMENTO OS CÓDIGOS: 0301010277 - avaliação do desenvolvimento da criança na puericultura e 03.01.01.026-9 AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO NA PUERICULTURA;

The image displays two screenshots of a medical software interface for pediatric evaluation. The top screenshot shows the 'AVALIAÇÃO' section with a dropdown for 'A98 - MEDICINA PREVENTIVA/MANUTENÇÃO DA SAÚDE' and a table for recording observations. The bottom screenshot shows the 'PROCEDIMENTO' section with a dropdown for '0301010277 - AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PUERICULTURA' and a table for recording observations.

2 CONSULTA DE PUERICULTURA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)

Consulta de acompanhamento de crescimento e desenvolvimento do nascimento até os 2 anos de idade.

1º Ano: 1ª semana, 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês.

2º Ano: Consultas aos 18 e 24 meses.

A partir do 2º ano de vida: Consultas anuais próximas ao mês do aniversário.

Tabela 1 – Calendário de Consultas de Puericultura na APS conforme estratificação de risco da criança.

Risco	1ª sem	1º m	2º m	3º m	4º m	5º m	6º m	7º m	8º m	9º m	10º m	11º m	12º m	15º m	18º m	21º m	24º m
RH	X	X	X		X		X			X			X		X		X
RI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
AR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.1 Estratificação de risco da criança:

Desde o momento da alta da maternidade e em todos os contatos da criança com os serviços de saúde, devem ser avaliadas as condições de risco apresentadas pela criança.

Crianças consideradas como de Alto Risco devem ter o cuidado na APS ainda mais intensificado e compartilhado com a AE, sendo a APS a ordenadora do cuidado e quem deve monitorar o seguimento. Lembrando que o acompanhamento especializado pode acontecer no setor terciário (Ex: HUSM);

Os critérios para estratificação de risco da criança, encontra-se no **Protocolo de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde - Saúde da Criança e do Adolescente - COREN - RS 2020 -**

Tabela 2 – Calendário de Consultas de Puericultura na Atenção Especializada

Estratificação de Risco	Número de atendimentos na AE
Alto Risco	4 atendimentos no 1º ano de vida 1 atendimento entre 15 e 18 meses 1 atendimento aos 24 meses de vida

Exemplos de condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento ao Pediatra:

- Alterações no Crescimento e Desenvolvimento;
- Asma de difícil manejo e outras pneumopatias;
- Cardiopatias;
- Nefropatias;
- Diabetes;
- Problemas neurológicos (Epilepsia, atraso da linguagem, paralisia cerebral, fechamento precoce da fontanela anterior, Suspeita de transtorno do Espectro Autista, Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, micro ou macrocefalia, etc);
- Hipertensão;
- Pós internações hospitalares.

3 TESTE DO PEZINHO - EVOYA:

- Procure o resultado pela **data de nascimento do RN e nome ou sobrenome da mãe**;
- Certifique-se que todos os filtros estão selecionados;
- Manter o campo GERADO em branco (assim vai localizar em qualquer data e não somente a partir de uma data).

Se mesmo fazendo todos estes passos ainda não encontrar o resultado, aqui vão outras dicas:

- Pode ser que o nome do RN ainda esteja com o nome da mãe: RN DE— (principalmente se coletado na UTI neonatal ou maternidade)
- Também pode ser que esteja com o outro sobrenome da mãe (pesquisar pelo dois ou mais, caso não encontre). ATENÇÃO ao escrever o nome da mãe no protocolo de envio para colocar corretamente e legível.

Figura 3

Painel de controle

396
AMOSTRAS

9.999+
RELATÓRIOS

Tarefas

As amostras inseridas remotamente não foram recebidas

396 Amostras pendentes de informações demográficas

Figura 4

Centro de download de arquivos

☐ 0 selecionado

Fazer download

Mesclar e baixar

Atualizar status

	Último Sobrenome do RN	Nome do RN	Data de nascimento	Último Sobrenome da mãe	Nome da mãe	Status do Laudo	Tipo de arquivo	Tipo de Laudo	Permis de Ace
☐	Q	Q	Q 04-0...	Q marcuzzo	Q				
☐	GOULART	LUISA MARCUZZO	04-05-2026	MARCUZZO	ANGELCA SAMPAIO	☐ Não Visualizado	Relatório	NORMAL	Respon

1 item

Se ainda não localizar o exame, realize a pesquisa utilizando apenas a data de nascimento. Dessa forma, serão exibidos todos os nascidos naquele dia, de todos os municípios, permitindo a conferência individual dos registros. Embora seja um processo mais trabalhoso, essa é uma forma de esgotar todas as possibilidades de busca.

Caso o exame ainda não seja encontrado, encaminhe um e-mail para a Política da Criança informando:

- Nome do recém-nascido (RN), se disponível;
- Nome da mãe;
- Data de nascimento.

4 INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL E FETAL

Os Comitês de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal são organismos de natureza interinstitucional, multiprofissional cuja atuação preserva o caráter confidencial, não coercitivo e/ou punitivo, ético, técnico, educativo e consultivo e tem por finalidade: analisar os óbitos maternos, infantis e fetais com o objetivo de identificação de fatores de evitabilidade; avaliar a qualidade da assistência à saúde prestada à mulher e à criança para subsidiar as políticas públicas com equidade; e

elaborar propostas de medidas de intervenção para redução desses óbitos considerando realidades diversas, modos de vida, cultura e situações de vulnerabilidade social.

4.1 Portaria nº 72, de 11 de janeiro de 2010

Estabelece que a vigilância do óbito infantil e fetal é obrigatória nos serviços de saúde (públicos e privados) que integram o Sistema Único de Saúde (SUS). Sendo assim, a Política de Saúde da Criança é responsável por investigar os óbitos junto ao comitê da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, quando acontece o óbito, deve ser solicitado às unidades de saúde o preenchimento das investigações ambulatoriais e domiciliares. A ficha ambulatorial deverá trazer as informações que constam em prontuário e demais documentos que comprovam os atendimentos realizados na UBS/ESF. A ficha domiciliar deve ser realizada por um membro da equipe assistencial, porém, em entrevista com algum responsável pela criança ou alguém do núcleo familiar que esteja disponível para conversar e elencar suas percepções acerca do ocorrido.

4.2 Fichas de investigação de óbito para a APS

4.2.1 Ficha de investigação de óbito infantil domiciliar

<https://svs.aids.gov.br/daent/cgiae/covivo/vigilancia-obito/mortalidade-infantil-fetal/I3-ficha-investigacao-obito-infantil-entrevista-domiciliar.pdf>

4.2.2 Ficha de investigação de óbito infantil ambulatorial

<https://svs.aids.gov.br/daent/cgiae/covivo/vigilancia-obito/mortalidade-infantil-fetal/I1-ficha-investigacao-obito-infantil-servico-saude-ambulatorial.pdf>

4.2.3 Ficha de investigação de óbito fetal domiciliar

<https://svs.aids.gov.br/daent/cgiae/covivo/vigilancia-obito/mortalidade-infantil-fetal/F3-ficha-investigacao-obito-fetal-entrevista-domiciliar.pdf>

4.2.4 Ficha de investigação de óbito fetal ambulatorial

<https://medicalseite.einstein.br/pratica-medica/Documentos%20Doencas%20Epidemicas/Ficha-investigacao-obito-fetal.pdf>

5 ESPECIALIDADES

5.1 Infectopediatria HUSM e HCS

Se o nascimento ocorrer no HCS, a criança ficará vinculada ao ambulatório de infectologia do HCS, caso não compareça à primeira consulta, a família ou preferencialmente a Unidade de Saúde deverá entrar em contato com o ambulatório e solicitar novo agendamento.

Se o nascimento ocorrer no HUSM, a criança ficará vinculada no ambulatório de infectologia do HUSM, caso não compareça na primeira consulta, a família deverá realizar novo agendamento no setor de agendamentos, e havendo duas faltas consecutivas, a criança perderá o vínculo, devendo ser encaminhada via GERCON para infectopediatria.

5.2 Teste da orelhinha, linguinha e teste do coraçãozinho

Quando a criança não realizou o teste da linguinha e orelhinha devido ter nascido em outro município ou no serviço privado, deve-se encaminhar via MV para emissões otoacústicas evocadas. No caso da equipe de saúde da APS identificar frênulo lingual curto, deverá encaminhar via GERCON para bucomaxilo.

Quando a criança não realizou o teste do coraçãozinho devido ter nascido em outro município ou no serviço privado, deve-se encaminhar para médico pediatria da policlínica via MV.

5.3 Vítimas de violência

Faz parte do plano anual de gestão o acompanhamento das crianças e adolescentes vítimas de violências pelas unidades de referência, após a notificação do caso, sendo assim a política de saúde da criança realiza o encaminhamento das fichas de compartilhamento para auxiliar na compreensão e busca ativa dos usuários. Os encaminhamentos para psicólogo podem ser feitos pelas unidades de saúde, porém é necessário observar algumas recomendações:

- Encaminhar como emergência somente casos de violência;
- Incluir CID relacionado a violência (sexual, física, psicológica, lesão autoprovocada, negligência e abandono), patologias mentais encaminhadas como urgência ou emergência serão negadas pela reguladora;

6 TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA- TEA

O TEA é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. Recomenda-se que toda a criança seja submetida à triagem de TEA na consulta de 18 meses, através da aplicação da escala M-CHAT-R (figura 5). O encaminhamento para o TEACOLHE se dá pelo GERCON, para Reabilitação Intelectual conforme critérios disponíveis no Protocolo 3-Regulação Ambulatorial disponível em:

<https://telessauders.ufrgs.br/protocolos/protocolo-de-reabilitacao-intelectual>

Figura 5: Modified Checklist for Autism in Toddlers M-CHAT-R

Por favor, responda as questões abaixo sobre o seu filho. Pense em como ele geralmente se comporta. Se você viu o seu filho apresentar o comportamento descrito poucas vezes, ou seja, se não for um comportamento frequente, então responda não. Por favor, marque sim ou não para todas as questões.		
1. Se você apontar para algum objeto no quarto, o seu filho olha para este objeto? (POR EXEMPLO, se você apontar para um brinquedo ou animal, o seu filho olha para o brinquedo ou para o animal?)	Sim	Não
2. Alguma vez você se perguntou se o seu filho pode ser surdo?	Sim	Não
3. O seu filho brinca de faz de contas? (POR EXEMPLO, faz de conta que bebe em um copo vazio, faz de conta que fala ao telefone, faz de conta que dá comida a uma boneca ou a um bichinho de pelúcia?)	Sim	Não
4. O seu filho gosta de subir nas coisas? (POR EXEMPLO, móveis, brinquedos em parques ou escadas)	Sim	Não
5. O seu filho faz movimentos estranhos com os dedos perto dos olhos? (POR EXEMPLO, mexe os dedos em frente aos olhos e fica olhando para os mesmos?)	Sim	Não
6. O seu filho aponta com o dedo para pedir algo ou para conseguir ajuda? (POR EXEMPLO, aponta para um biscoito ou brinquedo fora do alcance dele?)	Sim	Não
7. O seu filho aponta com o dedo para mostrar algo interessante para você? (POR EXEMPLO, aponta para um avião no céu ou um caminhão grande na rua)	Sim	Não
8. O seu filho se interessa por outras crianças? (POR EXEMPLO, seu filho olha para outras crianças, sorri para elas ou se aproxima delas?)	Sim	Não
9. O seu filho traz coisas para mostrar para você ou as segura para que você as veja – não para conseguir ajuda, mas apenas para compartilhar? (POR EXEMPLO, para mostrar uma flor, um bichinho de pelúcia ou um caminhão de brinquedo)	Sim	Não
10. O seu filho responde quando você o chama pelo nome? (POR EXEMPLO, ele olha para você, fala ou emite algum som, ou para o que está fazendo quando você o chama pelo nome?)	Sim	Não
11. Quando você sorri para o seu filho, ele sorri de volta para você?	Sim	Não
12. O seu filho fica muito incomodado com barulhos do dia a dia? (POR EXEMPLO, seu filho grita ou chora ao ouvir barulhos como os de liquidificador ou de música alta?)	Sim	Não
13. O seu filho anda?	Sim	Não
14. O seu filho olha nos seus olhos quando você está falando ou brincando com ele/ela, ou vestindo a roupa dele/dela?	Sim	Não
15. O seu filho tenta imitar o que você faz? (POR EXEMPLO, quando você dá tchau, ou bate palmas, ou joga um beijo, ele repete o que você faz?)	Sim	Não
16. Quando você vira a cabeça para olhar para alguma coisa, o seu filho olha ao redor para ver o que você está olhando?	Sim	Não
17. O seu filho tenta fazer você olhar para ele/ela? (POR EXEMPLO, o seu filho olha para você para ser elogiado/aplaudido, ou diz: “olha mãe!” ou “óh mãe!”)	Sim	Não
18. O seu filho compreende quando você pede para ele/ela fazer alguma coisa? (POR EXEMPLO, se você não apontar, o seu filho entende quando você pede: “coloca o copo na mesa” ou “liga a televisão”)?	Sim	Não
19. Quando acontece algo novo, o seu filho olha para o seu rosto para ver como você se sente sobre o que aconteceu? (POR EXEMPLO, se ele/ela ouve um barulho estranho ou vê algo engraçado, ou vê um brinquedo novo, será que ele/ela olharia para seu rosto?)	Sim	Não
20. O seu filho gosta de atividades de movimento? (POR EXEMPLO, ser balançado ou pular em seus joelhos).	Sim	Não
Para todos os itens, a resposta “NÃO” corresponde a um ponto; exceto para os itens 2, 5 e 12, nos quais “SIM” indica um ponto cada. Suspeita diagnóstica de TEA: resultado maior ou igual a 3 pontos.		

A escala M-CHAT-R auxilia na identificação de pacientes com idade entre 16 e 30 meses com possível TEA. Ela é de rápida aplicação, pode ser aplicada por qualquer profissional da saúde, devendo ser respondida pelos pais ou cuidadores durante a consulta. Ela indica suspeita de TEA e não é diagnóstica. Resultados falso-negativos são possíveis e se o resultado da triagem não for positivo, recomenda-se acompanhamento e monitoramento do desenvolvimento neuropsicomotor da criança e reavaliação.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2022), adaptado de Losapio *et al.* (2020).

7 REABILITAÇÃO FÍSICA

Casos que necessitem de encaminhamento para APAE/CER- devem ser encaminhado via GERCON para Reabilitação Física conforme critérios disponíveis no link do Protocolo <https://telessaunders.ufrgs.br/protocolos/protocolo-de-reabilitacao-fisica>

